EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 47694
SERVICIO : UTI HSC
FECHA : 26-05-2022

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: NORMA FUENTES ACU►A			RUN	: 6.175.758-9
F.Nac	: 15-05-1945	Edad	: 77 AÑOS	Género	: Femenino
Dirección	: CHACAY			Comuna	: NIQUEN
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 940081402		
Fecha Ingreso	: 07-05-2022	Fecha Egreso	: 26-05-2022	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: DOMICILIO	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I21.9-INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. IAM C/SDST CARA INFERIOR KILLIP II
2. ENFERMEDAD CORONARIA OBSTRUCTIVA DE 1 VASO
a. ESTENOSIS ARTERIA CORONARIA DERECHA MEDIA 90%
b. PTCA + IMPLANTE DE STENT FARMACOACTIVO A ACD MEDIA
3. BAV 3ER GRADO POST IAM
a. MCPD MEDTRONIC SPHERA (SN FNCO28099G) 23/05/2022
4. NEUMOBILIA POST CPRE (ANTIGUA)
5. DM TIPO 2 NO INSULINO REQUIRIENTE
6. TABAQUISMO CRÓNICO ACTIVO
7. OBESIDAD VISCERAL
8. DISLIPIDEMIA MIXTA

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I21-INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO. (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. I44.2-BLOQUEO AURICULOVENTRICULAR COMPLETO. (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. E10-E14-DIABETES MALLITUS (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

ANTECEDENTES MÓRBIDOS:
DM TIPO 2, TABAQUISMO
FCOS: METFORMINA 850 MG 1 COMPRIMIDO 1 VEZ AL DÍA

RESUMEN DE ANAMNESIS:
EL DÍA 07/05/2022 COMIENZA CON DOLOR TORACICO RETROESTERNAL MOTIVO POR LOS CUALES ACUDE A SERVICIO DE URGENCIA HSC DONDE INGRESA HIPERTENSA PA 170/100 TAQUICARDICA FC 100, SE REALIZA EKG EVIDENCIANDO SUPRADESNIVEL DE SEGMENTO ST CARA INFERIOR, SE ADMINISTRA TERAPIA ANTIISQUEMICA Y SE TRASLADA A HLHT DONDE SE PRACTICA CORONARIOGRAFIA DETECTANDO ESTENOSIS 90% ACD, SE REALIZA PTCA + IMPLANTE DE STENT FARMACOACTIVO DE FORMA EXITOSA., PERO EVOLUCIONANDO CON INESTABILIDAD HEMODINAMICA Y BAV 3ER GRADO, AMERITANDO USO DE DVA E INSTALACIÓN DE SONDA MARCAPASO COMO SOPORTE. POSTERIORMENTE RETORNA A HSC INGRESANDO A UPC

EVOLUCION POR SISTEMAS
CARDIOLOGICO: INGRESA NORMOTENSA, SIN DOLOR TORACICO, NO EDEMA, SE MANTIENE CON ALTERNANCIA DE RITMO SINUSAL (55-60 LPM) Y BOQUEO AV II Y III GRADO PAROXÍSTICO. HOLTER DE ARRITMIA AL 8VO DIA DE VOLUCIÓN DETECTANDO BAV III GRADO INTERMITENTE, RITMO NODAL. EL 23/05 SE INSTALO MCPD EN HGGB, SIN INCIDENTES, QUEDANDO OPERATIVO. LUEGO SE MANTIENE ESTABLE ASINTOMÁTICA CARDIOVASCULAR, EN

RITMO SINUSAL, RECIBIENDO TERAPIA DE PREVENCION 2RIA Y CON INDICACIÓN DE CONTROL EN 15 DIAS EN POLICLINICO DE MARCAPASOS HGGB CON ENFERMERIA (SERA LLAMADA PARA CITACION). NO RETIRAR TEGADERM

INFECCIOSO: INGRESA AFEBRIL PERO A PARTIR DEL 15/05/2022 EMPIEZA A ELEVAR PARAMETROS INFLAMATORIOS CON PCR EN 150 Y QUE LLEGA HASTA 163 EL 18/05/2022 ACOMPAÑADO DE FIEBRE. SE PANCULTIVO Y LUEGO INICIA ATB EMPIRICA CON TAZONAM /VANCOMICINA. TACTORAX SIN NEUMONIA, TODOS LOS CULTIVOS RESULTAN NEGATIVOS. VANCOMICINA SE SUSPENDE LUEGO DE QUE LLEVABAN MÁS DE 72 HORAS Y TAZONAM A LOS 7 DÍAS. LUEGO SE MANTIENE AFEBRIL Y PARAMETROS INFLAMATORIOS BAJOS

HEPATOBILIAR: CON ANTECDENTE DE COLECISTECTOMIA POR COLELITIASIS Y CPRE, EN ESTUDIO CON TAC REALIZADO SE INFORMA NUEMOBILIA. PRESENTO DISCRETA ELEVACION DE GGT Y FA. SE ESTUDIA CON ECOGRAFIA ABDOMIAL CORROBORANDO NEUMOBILIA Y DESCARTANDO FACTOR OBSTRUTIVO. SIEMPRE ASINTOMATICA EN LO BILIAR. EVALUADO POR CIRUGIA PLANTEA NEUMOBILIA ANTIGUA 2RIA A INTERVENCION VÍA BILIAR (POST CPRE) SE INDICA CONTROL AMBULATORIO EN POLICLINICO CIRUGIA HSC

RESPIRATORIO: EUPNEICA DESDE SU INGRESO, TOLERANDO FIO2 AMBIENTAL SIN DESATURACIONES, DURANTE SU EVOLUCIÓN LLEGA A PRESENTAR TOS PRODUCTIVA. SE INDICA BRONCODILATADORES Y KNT. EN CONTROL RADIOLOGICO SE APRECIA ELEVACIÓN DE HEMIDIAFRAGMA DERECHO. EVOLUCIONA ASINTOMÁTICA EN SIN DESATURACIONES.

PLAN DE MANEJO:

CONTROL EN POLICLINICO MARCAPASO EN 15 DIAS (SERA LLAMADA PARA CITACION).
CONTROL EN POLICLINICO IAM HSC EN 30 DIAS
CONTROL EN POLICLINICO DE CIRUGIA EN 30 DIAS (PARA SEGUIMIENTO POR NEUMOBILIA)

INDICACIONES AL ALTA

1. REPOSO RELATIVO
2. REGIMEN LIVIANO PARA DIABETICOS-HIPOSÓDICA-BAJA EN LIPIDOS
3. ENALAPRIL 5 MG VO 1 VEZ AL DIA
4. ASPIRINA 100 MG DIA VO
5. CLOPIDOGREL 75 MG DIA VO
6. ATORVASTATINA 80 MG VO 1 VEZ AL DIA
7. CARVEDILOL 3.125 MG C/ 12 HRS VO
8. METFORMINA 850 MG PRE ALMUERZO Y CENA
9. PARACETAMOL 1 GR VEV CADA 8 H X 3 DIAS
10. NO RETIRAR PARCHE SOBRE MCPD HASTA CONTROL EN POLICLINICO MARCAPASO

Control en: 30 días en HOSPITAL DE SAN CARLOS

Cristian Mella Inzunza
MEDICO TRATANTE
14059309-5

JEFE SERVICIO